

# La Famiglia

I Tempi della Vita · Sessione 05 · A.A. 2025–2026

Questa lezione è un po' come studiare l'ecosistema di una foresta: la famiglia non è un singolo albero, ma un intreccio di radici, rami e specie diverse che si evolvono nel tempo. Capire come funziona — biologicamente, psicologicamente, socialmente — è fondamentale per chi fa lavoro sociale. Niente grafici d'esame vuoti: solo concetti che userai davvero sul campo.

---

## Che cos'è la famiglia? Definizioni a confronto

La domanda sembra banale, ma non lo è. Il punto di partenza della lezione è proprio questo: **non esiste una definizione universale di famiglia**, e capire perché è già metà del lavoro.

**Lévi-Strauss** identificava tre pilastri che legano famiglia e società: - la **proibizione dell'incesto** - una **forma riconosciuta di unione** - la **divisione sessuale dei compiti**

Ma oggi queste categorie scricchiolano. La coppia, il genitore, la famiglia stessa hanno assunto forme che sfidano ogni schema classico.

| Fonte                        | Definizione                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scabini & Cigoli (2000)      | Organizzazione che lega differenze fondamentali: generi, generazioni e stirpi — con la <b>generatività</b> come progetto centrale |
| Vegetti Finzi & Celli (2011) | Due persone legate da vincolo sociale, che condividono casa, figli e impegni comuni                                               |
| Dizionario Devoto Oli        |                                                                                                                                   |

| Fonte             | Definizione                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Nucleo sociale di due o più individui che vivono insieme, legati da matrimonio, parentela o affinità ( <i>dal lat. "famulus" = servo</i> ) |
| Delvecchio (2013) | <b>Sistema complesso</b> derivante da storie, esperienze e relazioni — non riducibile alla somma dei suoi membri                           |
| Fruggeri (2005)   | Non più un'istituzione, ma un' <b>unione di affetti</b>                                                                                    |
| Colozzi (2009)    | Il <b>topos</b> delle certezze — il luogo sicuro dove rifugiarsi in un mondo esterno frammentato                                           |

La svolta concettuale chiave: i sociologi ormai parlano di **"famiglie" al plurale**, non più di "famiglia". Un singolo individuo può attraversare più forme familiari nel corso della vita.

### Tipologie di organizzazioni familiari (Alvaro et al., 2007)

Nucleare · Monoparentale · Ricomposta · Omo-genitoriale · D'affido · Adottiva · Da procreazione assistita · Di genitori separati · Unipersonale · LAT (*Living Apart Together*) · DINKS (*Double Income, No Kids*)

---

## Sguardo antropologico: cosa significa davvero "genitore"?

Prima di parlare di crisi della genitorialità, l'antropologia ci offre uno strumento prezioso per decostruire il concetto.

**Esther Goody (1976, 1999)** ha scomposto la genitorialità in **cinque funzioni**, che nelle società occidentali tendono a concentrarsi sulle stesse persone, ma in altre culture (africane, studiate da Goody) vengono distribuite tra più adulti:

1. Concepire e mettere al mondo
2. **Nutrire**
3. **Educare**

4. Dare un'identità alla nascita
5. Garantire l'accesso allo statuto di adulto

Pensa alle radici di una pianta: nella nostra cultura tendiamo a volerle tutte concentrate nello stesso vaso (padre + madre biologici). In altre culture, ogni radice può nutrirsi da un substrato diverso, e la pianta cresce comunque.

## Dissociazione della genitorialità

Oggi si distingue tra: - **Genitorialità biologica** — chi concepisce - **Genitorialità istituzionale/giuridica** — chi ha il riconoscimento legale - **Genitorialità domestica** — chi si occupa della cura quotidiana

Il sistema occidentale rimane ancorato a tre principi nella filiazione: - **Bilateralità** (due genitori riconosciuti) - **Ideologia del sangue** (legame biologico come primario) - **Esclusività** (un solo set di genitori "veri")

Questo crea tensioni evidenti con le nuove forme di plurigenitorialità (famiglie adottive, ricomposte, omo-genitoriali, ecc.).

---

## Evoluzione storica della famiglia occidentale

La famiglia nucleare si è consolidata come modello tra il XVI e il XVII secolo. Tre periodi principali:

### Famiglia tradizionale (XVI–XVIII sec.)

- Famiglia dell'*Ancien Régime*: il **padre** esercita autorità assoluta
- Donne e figli sottomessi alla sua volontà
- L'amore romantico era percepito come **pericoloso** per le strategie familiari (il matrimonio unisce stirpi, non individui)

### Famiglia moderna (fine XVIII – XX sec.)

- Il Padre-tiranno cede il posto al padre affettuoso; il **bambino viene posto al centro**

- Attenzione affettiva ed educativa verso i bambini
- Ma nel 1803 il **codice civile napoleonico ristabilisce la potenza paterna**
- Rigida divisione dei ruoli; inferiorità giuridica della moglie

## **Famiglia contemporanea / post-moderna (fine anni '60 in avanti)**

Il punto d'inflessione demografico è il **1965**: calano fecondità, nuzialità, aumentano divorzi e matrimoni tardivi.

Cambiamenti strutturali: - Nuovo ruolo della **donna** (lavoratrice, autonoma, portavoce di nuovi diritti) - Ridimensionamento del modello **patriarcale** - Valorizzazione della **soggettività individuale** e dell'autorealizzazione - Coniugalità "privatizzata": il matrimonio come scelta personale, non un obbligo sociale - **Precarizzazione dell'unione** di coppia

---

## **Cambiamenti culturali nella transizione alla genitorialità**

*(Scabini & Cigoli, 2000)*

Quattro trasformazioni fondamentali che caratterizzano la genitorialità contemporanea:

**1. Si diventa genitori più tardi nella vita** L'età media al primo figlio si è spostata significativamente in avanti in tutto l'Occidente.

**2. Avere figli è diventato sempre più raro** Fenomeno noto come "**seconda transizione demografica**" (Lesthaeghe & Van de Kaa, 1986): calo strutturale della fecondità, disallineamento tra tassi di natalità e mortalità. In Svizzera il tasso di fertilità è tra i più bassi d'Europa.

Principali motivazioni per la scelta di non avere figli (De Pierrepont & Lévy, 2017): - Percezione negativa di bambini e gravidanza - Assenza di desiderio genitoriale - Rifiuto dei vincoli e dei ruoli legati alla genitorialità - Motivazioni altruistiche

(preoccupazioni etiche/ambientali) - Valori post-moderni: soddisfazione di bisogni "postmaterialisti"

**3. La nascita è sempre più un evento scelto** Si passa dalla nascita come **evento atteso** (imprevedibile, estraneo alla pianificazione) alla nascita come **evento pianificato** (carico di aspettative e, a volte, di senso di colpa se le cose non vanno come previsto).

In un contesto di relazioni sempre più frammentate, il figlio diventa il **nuovo principio organizzatore dei legami familiari** — un "figlio del bisogno", posto al centro della realizzazione personale.

Si passa dalla **famiglia etica** (che trasmette valori e norme) alla **famiglia affettiva** (fondata sull'amore e sul legame emotivo — Pietropolli Charmet, 2000).

«I genitori tendono a trasmettere amore più che regole e principi astratti, aspirano a farsi obbedire per amore e non per paura delle sanzioni, si piegano nei confronti del figlio nella prospettiva di intercettare quale sia la sua vera natura e indole.» — Pietropolli Charmet, 2000

**4. Mutano le aspettative dei ruoli** Le donne hanno aspettative sempre più elevate di un **impegno paritario e condiviso** da parte dei partner nella gestione familiare.

---

## Il processo di accesso alla genitorialità

*(Nanzer & Palacio Espasa)*

Diventare genitore non è solo un fatto biologico — è un **processo psichico profondo** che inizia nell'infanzia ma si intensifica nel **periodo perinatale** (dal concepimento ai primi due anni dopo il parto).

Durante questa fase: - La donna attraversa un periodo di "**trasparenza psichica**": estrema sensibilità emotiva, riemersione del passato - Il genitore compie un **movimento regressivo** verso i propri vissuti infantili - Emergono

domande fondamentali: *"Che genitore sarò? Come erano i miei genitori? Voglio essere uguale o diverso/a?"*

Il processo implica **lutti di sviluppo**: occorre rinunciare a immagini idealizzate dei propri genitori, o elaborare perdite reali vissute nell'infanzia.

Fin qui ci siamo? Bene. Perché adesso viene la parte che, come futuro assistente sociale, tornerà più spesso nella tua pratica.

Quando questi lutti sono **ben elaborati** → la genitorialità diventa un'occasione di crescita e "riedizione corretta" delle relazioni infantili.

Quando **non lo sono** → il bambino rischia di essere inconsciamente arruolato per riparare o compensare ciò che il genitore non ha elaborato.

Come in un videogioco in cui un personaggio deve completare le quest non finite di un altro: il bambino porta il peso delle storie irrisolte dei genitori.

Anche le tappe di sviluppo del bambino (edipo, latenza, adolescenza) possono **riattivare** conflitti irrisolti nel genitore — per esempio, l'adolescenza del figlio mobilita spesso i vissuti dell'adolescenza del genitore.

---

## I conflitti della genitorialità: quattro livelli

*(da Cramer & Palacio Espasa 1993; Manzano, Palacio Espasa & Zilkha 1999)*

Il meccanismo centrale è quello delle **identificazioni proiettive**: il genitore proietta sul bambino immagini di sé da bambino, o dei propri genitori. Queste proiezioni possono essere sane e flessibili, oppure rigide e deformanti.

Freud (1914) aveva già intuito che i genitori rendono i figli depositari del proprio narcisismo infantile a cui hanno dovuto rinunciare.

### Livello 1 — Genitorialità "normale"

- Identificazioni proiettive **flessibili e bidirezionali** ("esternalizzanti")

- Il genitore si mette al posto del bambino *e* sa tornare al proprio punto di vista (empatia funzionale)
- Le immagini proiettate sono prevalentemente **positive e libidiche**
- Con il tempo queste immagini **sfumano**, lasciando spazio alla specificità del bambino reale

*Esempio:* "Ho avuto un'infanzia buona nel complesso. Mi arrabbio a volte coi miei genitori, ma la nostra relazione è solida. Faccio del mio meglio con mio figlio, non sono perfetto ma stiamo bene."

## Livello 2 — Genitorialità nevrotica

- Il bambino viene **usato inconsciamente** per negare o riparare dolori infantili del genitore
- Il genitore proietta sul bambino un'immagine idealizzata (il bambino che lui avrebbe voluto essere)
- Si identifica con un genitore ideale: presente, disponibile, tollerante — ciò che i suoi genitori non erano stati abbastanza
- Obiettivo inconscio: "**riscrivere la storia**" infantile
- Narcisismo "antidepressivo": lo scopo è evitare i sentimenti di privazione, non attaccare il bambino
- Impatto: disturbi di separazione, sonno, alimentazione, comportamento nel bambino
- In terapia: **pre-transfert positivo** verso il terapeuta

*Esempio:* "La partenza di mio padre mi ha lasciato una mancanza. Voglio che mio figlio abbia l'infanzia perfetta che non ho avuto."

## Livello 3 — Genitorialità masochistica

Due varianti: 1. Il genitore si è vissuto da bambino come **responsabile della tristezza/depressione dei propri genitori** 2. Il genitore ha coltivato **rivendicazioni** verso genitori vissuti come abbandonanti o indegni

Dinamica: proietta sul bambino l'immagine del bambino-difficile, identificandosi col genitore-vittima. Si **sottomette** alla tirannia del bambino come espiazione.

Impatto: disturbi del comportamento più gravi, disturbi ansiosi o dell'umore nel bambino.

In terapia: **pre-transfert positivo**, ma il terapeuta deve fare attenzione a non mostrarsi colpevolizzante (il Super-Io già spinge all'espiazione).

*Esempio:* "I miei genitori hanno sacrificato tutto per me, sembravano sempre tristi. Oggi mio figlio fa solo di testa sua — ho l'impressione che cerchi di farmi pagare quello che ho fatto passare ai miei genitori."

## Livello 4 — Genitorialità narcisistica

Il livello più grave. Le identificazioni proiettive sono: - **Rigide, unidirezionali, evacuatrici e deformanti** - Il genitore proietta aspetti **negativi** di sé (avidità, aggressività, pericolo) sul bambino - Genera un senso di persecuzione: il bambino viene vissuto come ostile o estraneo - Difese intense: **diniego e scissione** — il genitore è tagliato dalla propria vita emotiva - Anamnesi del passato vuota: *"Un'infanzia normale, come tutte le altre..."* - **Pre-transfert negativo**: il terapeuta viene vissuto come persecutore

Impatto sul bambino: gravi disturbi dell'attaccamento, depressioni, disarmonie evolutive o psicotiche. A lungo termine: disturbo della personalità.

*Esempio:* "La mia infanzia? Non ho niente da dire. Oggi non capisco mio figlio — non mi ascolta, penso che non mi voglia bene."

---

## I casi clinici: la teoria in azione

### Caso Myriam — "L'erede psicologica"

*(Palacio Espasa, Manzano & Zilkha — dal volume "Scenari della genitorialità")*

**La situazione:** Myriam, 11 anni e mezzo, adottata fin da piccola. Difficoltà scolastiche gravi, tristezza, inibizione, conflitti col fratello. La madre ha scelto l'adozione specificamente per **rompere con una linea ereditaria di gravi depressioni** nella sua famiglia d'origine — ma ora vede Myriam triste.



**La dinamica:** - La madre proietta su Myriam l'immagine della **propria madre depressa** - Spera di recuperare il legame con la madre, "guarirla" e accedere a un'immagine migliore di sé - Il meccanismo fallisce: Myriam diventa ugualmente triste, confermando la proiezione - La bambina **si identifica istericamente** con gli aspetti depressivi proiettati — probabilmente per mantenere l'interesse della madre

**L'intervento terapeutico:** - Primo intervento della terapeuta: *"Penso che siate molto tristi tutte e due, e tristi che anche l'altra lo sia."* La madre piange, Myriam si avvicina a lei. - Successivamente: la madre si riappropria della propria depressione e chiede una psicoterapia per sé - A Myriam vengono proposte sedute individuali centrate sulla problematica isterica (rivalità fallica, angosce di separazione) - **Esito:** Myriam completa l'anno scolastico con successo, sviluppa nuove relazioni coi coetanei e si autonomizza

**Concetto chiave:** fuggendo l'eredità biologica (la depressione genetica), la madre ha costruito ugualmente un'**eredità psicologica**. Il sintomo di Myriam era il lutto irrisolto della madre travestito da tristezza della figlia.

---

## **Caso Régine — "Il sorriso di sollievo"**

*(Palacio Espasa, Manzano & Zilkha)*

**La situazione:** Régine, 9 anni. Difficoltà di separazione severa: non riesce a dormire fuori casa, si angoschia quando qualcuno in famiglia perde un oggetto, pensa costantemente alla famiglia quando è lontana. La madre ha perso entrambi i genitori: il padre 12 anni prima, la madre quando era adolescente.

**La dinamica:** - La madre proietta su Régine l'immagine della **"buona madre" che protegge dalla perdita** — quella madre che lei non ha avuto/ha perso - Régine **si identifica con l'oggetto proiettato:** diventa la bambina che non abbandona la mamma, per non farla sentire sola - Il sintomo — l'angoscia di separazione — è in realtà il lutto della madre che la bambina porta per lei

**L'intervento terapeutico:** Un unico intervento, rivolto alla bambina ma destinato anche alla madre:

*"Prima la mamma era molto preoccupata che tu rischiassi di essere triste, e adesso sei tu che pensi che non devi lasciare la mamma."*

La madre rimane stupita. Régine **sorride sollevata**. Nella stessa seduta, le due organizzano insieme un breve soggiorno da una cugina.

**Esito:** in una sola consultazione, il sintomo si dissolve perché la bambina viene liberata dal peso della proiezione.

**Concetto chiave:** il sintomo di Régine non era suo — era il lutto irrisolto della madre che la bambina portava in nome di lei. Liberata da questo compito, Régine può finalmente essere una bambina.

---

## **Plurigenitorialità e spazio psichico del bambino**

Le famiglie ricomposte, adottive e plurigenitoriali pongono sfide specifiche per il bambino:

- Le **modificazioni brusche** dell'ambiente familiare mettono in pericolo la **continuità narcisistica** del bambino
- È fondamentale **dare senso alle trasformazioni**: mettere in parole l'inatteso, aiutare il bambino a costruire una narrativa coerente della propria storia
- Ammettere la **bilinearità delle origini**: il bambino cresciuto nella certezza della propria doppia origine riesce a trovare il "terzo" accanto alla madre — ciò che dà senso alle assenze e agli "abbandoni"

**Rispettare lo spazio psichico del bambino significa:** - Spiegargli, in modo misurato, quello che succede - Accettare che abbia sentimenti e opinioni proprie, anche scomodi - Dargli il **diritto al segreto** - Aiutarlo a conservare buoni ricordi degli assenti - Prendere misura delle discontinuità che vive

---

# Nuove pratiche di genitorialità e conseguenze per i bambini

(Lazartigues, 2000)

Nella famiglia contemporanea, l'**edonismo** — la ricerca di piacere immediato — ha preso il posto del dovere come valore centrale trasmesso ai figli.

Conseguenze osservate: - **Ridotta tolleranza alla frustrazione** e all'attesa - Malessere e comportamenti **auto/eteroaggressivi** o di evitamento - Difficoltà nell'integrazione del **senso morale**

---

## Concetti chiave

| Termine                                                    | Significato                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genitorialità</b>                                       | Insieme delle funzioni svolte dal genitore verso il figlio (biologica, nutritiva, educativa, identitaria, di accesso all'età adulta) |
| <b>Plurigenitorialità</b>                                  | Distribuzione delle funzioni genitoriali su più figure adulte                                                                        |
| <b>Genitorialità biologica / istituzionale / domestica</b> | Tre dimensioni dissociabili della genitorialità contemporanea                                                                        |
| <b>Seconda transizione demografica</b>                     | Calo strutturale della fecondità dal dopoguerra, legato a cambiamenti valoriali                                                      |
| <b>Trasparenza psichica</b>                                | Stato di estrema sensibilità della donna in gravidanza: riemersione del passato infantile                                            |
| <b>Lutti di sviluppo</b>                                   | Rinunce psichiche necessarie per diventare genitore                                                                                  |
| <b>Identificazioni proiettive</b>                          | Meccanismo per cui il genitore proietta sul figlio immagini di sé o dei propri genitori                                              |

| Termine                           | Significato                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genitorialità nevrotica</b>    | Bambino usato per riparare dolori infantili irrisolti — proiezioni empatiche ma vincolanti                                                |
| <b>Genitorialità masochistica</b> | Il genitore si sottomette al bambino per espiare sensi di colpa del passato                                                               |
| <b>Genitorialità narcisistica</b> | Proiezioni rigide e deformanti; pre-transfert negativo; gravi conseguenze per il bambino                                                  |
| <b>Pre-transfert</b>              | Atteggiamento iniziale del genitore verso il terapeuta, influenzato dalle proiezioni sulle figure d'autorità                              |
| <b>Famiglia affettiva</b>         | Modello post-moderno fondato sull'amore e sulla realizzazione emotiva (vs. famiglia etica, basata sulla trasmissione di valori normativi) |
| <b>Bilinearità delle origini</b>  | Riconoscimento delle due linee di provenienza del bambino, fondamentale nelle famiglie ricomposte/adottive                                |

## Collegamenti

- **Lezione 01 (ciclo di vita):** la genitorialità come transizione identitaria — uno dei momenti di crisi/sviluppo del ciclo vitale
- **Lezione 04 (coppia):** la coppia come sistema che precede la genitorialità; le sue dinamiche influenzano il processo genitoriale
- **Da approfondire:** psicoterapia madre-bambino (Cramer & Palacio Espasa 1993); teoria dell'attaccamento (Bowlby); "fantasmi nella nursery" (Fraiberg et al.)